

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Inventario de Sensibilización Central (Central Sensitization Inventory) (CSI)

Eje VI • Versión de trabajo: 10 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1. Identificación

Familia / sigla	CSI
Nombre completo	Central Sensitization Inventory — Inventario de Sensibilización Central
Versión / edición	Versión española validada (Cuesta-Vargas et al., 2016), 25 ítems Parte A + 10 ítems Parte B (no puntuable).
Idioma	Español.
Autores (original)	Mayer TG, Neblett R, Cohen H, Howard KJ, Choi YH, Williams MJ, Perez Y, Gatchel RJ (PRIDE Research Foundation). Validación española: Cuesta-Vargas AI, Roldan-Jimenez C, Neblett R, Gatchel RJ.
Año (original / validación española)	2012 (original); 2016 (validación española).
Tiempo estimado	Menos de 5 minutos

2. Eje y pregunta clínica

Eje primario	EJE VI - SALUD FÍSICA, ESTILO DE VIDA Y MEDICINA CONDUCTUAL
Etiquetas	Sensibilización central; síndromes de sensibilidad central; dolor crónico; carga de síntomas somáticos y emocionales.
Pregunta clínica que responde	¿Qué factores corporales/médicos/conductuales inciden?

3. Constructo, finalidad y usos

Constructo evaluado: carga de síntomas somáticos y emocionales asociados a la sensibilización central (SC) y a los síndromes de sensibilidad central (fibromialgia, síndrome de colon irritable, cefalea/migraña, disfunción temporomandibular, síndrome de piernas inquietas, fatiga crónica,

sensibilidad química múltiple), junto con comorbilidad autoinformada con ansiedad, depresión y trauma.

Finalidad: cribado de síntomas que puedan indicar sensibilización central o la presencia de un síndrome de sensibilidad central, para orientar evaluación diagnóstica adicional y decisiones de tratamiento (el propio autor aclara que el CSI no mide sensibilización central directamente, ya que ningún autoinforme puede hacerlo).

Usos apropiados:

- Cribado inicial de posible sensibilización central en pacientes con dolor crónico o síntomas somáticos de causa poco clara.
- Seguimiento de la evolución de síntomas asociados a sensibilización central a lo largo del tratamiento (uso como medida de resultado, con evidencia preliminar).
- Apoyo a la decisión de evaluar específicamente síndromes de sensibilidad central (fibromialgia, colon irritable, etc.) antes de solicitar pruebas médicas invasivas innecesarias.

Usos NO apropiados:

- Diagnóstico de sensibilización central o de cualquier síndrome de sensibilidad central específico: el CSI es un instrumento de cribado, no diagnóstico.
- Sustituto de evaluación médica, reumatológica o neurológica cuando existan signos de alarma que requieran descartar patología estructural.
- Uso de subescalas factoriales específicas para decisiones clínicas individuales: la evidencia multinacional (Cuesta-Vargas et al., 2017) recomienda usar solo la puntuación total, dada la baja fiabilidad de las subescalas.

4. Población, contexto, informante y modalidad

Población	Adultos con dolor crónico u otros síntomas somáticos de etiología poco clara; también usado en muestras no clínicas para comparación.
Contexto de aplicación	Medicina del dolor, reumatología, fisioterapia, atención primaria, salud mental (comorbilidad con ansiedad/depresión/trauma).
Informante	Autoinforme.
Modalidad de administración	Papel y lápiz o formato electrónico; individual.

5. Estructura y administración

Número de ítems	25 (Parte A, puntuable) + 10 (Parte B, informativo)
Periodo temporal de referencia	Actualidad / Sin ventana temporal explícita
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (Nunca, Rara vez, A veces, A menudo, Siempre)
Tiempo estimado de aplicación	No verificado en las fuentes consultadas (estimación editorial: 5-10 minutos, dados los 25 ítems de Parte A).

6. Dimensiones y puntuaciones

La estructura factorial difiere entre estudios: la versión original inglesa y varias traducciones (francés, portugués brasileño) encuentran una estructura de 4 factores (Síntomas Físicos, Distrés Emocional, Cefalea/Mandíbula, Síntomas Urológicos); la validación ESPAÑOLA (Cuesta-Vargas et al., 2016) encontró una estructura de UN SOLO FACTOR mediante análisis de componentes principales con extracción de máxima verosimilitud. Un estudio multinacional posterior (Cuesta-Vargas et al., 2017, con datos españoles incluidos) confirmó 4 factores ortogonales pero con fiabilidad insuficiente para uso como subescalas, recomendando usar solo la puntuación total.

7. Sistema de puntuación

Regla de puntuación	Suma de los 25 ítems de la Parte A (rango 0-100). La Parte B no se puntúa, es solo informativa sobre diagnósticos previos.
Ítems invertidos	No se identifican ítems inversos; los 25 ítems puntúan en el mismo sentido (mayor frecuencia = mayor puntaje).
Ítems omitidos / reglas de omisión	No verificado en las fuentes consultadas.
Rango posible / puntos de corte	0-100. Punto de corte ≥ 40 sugiere posible sensibilización central/síndrome de sensibilidad central (sensibilidad 81%, especificidad 75% en la muestra estadounidense original de Neblett et al., 2013). Niveles de severidad (Neblett et al., 2017): subclínico 0-29, leve 30-39, moderado 40-49, severo 50-59, extremo 60-100. Estos cortes provienen de la muestra

	estadounidense original; no se verificó su recalibración específica en la muestra española.
--	---

8. Evidencia psicométrica en español / LatAm

Cuesta-Vargas AI, Roldan-Jimenez C, Neblett R, Gatchel RJ (2016). Cross-cultural adaptation and validity of the Spanish central sensitization inventory. SpringerPlus, 5, 1837 (N=395, dos Centros de Atención Primaria en España). Resultados: consistencia interna $\alpha=0.872$; fiabilidad test-retest $r=0.91$; estructura de un solo factor (PCA/MLE). El instrumento ha sido posteriormente incluido en un estudio multinacional agrupado (Cuesta-Vargas et al., 2017, N $\approx$ 1987, con muestra española) que confirmó una estructura bifactorial con un factor general de 'Síntomas relacionados con SC' de alta fiabilidad ($\alpha=0.92$; $\omega=0.95$).

9. Adaptación cultural y norma local

Adaptación transcultural formal a población española (Cuesta-Vargas et al., 2016), con doble traducción directa e inversa. No se verificó en esta sesión una adaptación normativa específica para países de Latinoamérica — no verificado.

10. Límites clínicos, seguridad, derivación y no-diagnóstico

- El propio autor del instrumento (Neblett, 2018) aclara explícitamente: 'el CSI no mide sensibilización central per se — ningún autoinforme puede hacerlo'; mide síntomas asociados, no el mecanismo neurofisiológico en sí.
- Es un instrumento de cribado, no diagnóstico; un puntaje elevado debe motivar evaluación clínica adicional, no un diagnóstico automático.
- El punto de corte de 40 y los niveles de severidad provienen de la muestra estadounidense original; su aplicabilidad exacta a la población española no fue recalibrada de forma independiente en la verificación realizada en esta sesión.
- La estructura factorial difiere entre estudios (1 factor en España vs. 4 factores en otras muestras); se recomienda usar solo la puntuación total, no subescalas, siguiendo la recomendación del estudio multinacional.
- No emplear como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.

11. Titular, licencia y condiciones de reproducción

El CSI es un instrumento de investigación de uso académico/clínico ampliamente distribuido en sus validaciones lingüísticas oficiales (coordinadas por el grupo PRIDE Research Foundation, autor: Randy Neblett). El texto español se accedió a través del repositorio de materiales del grupo de investigación Pain in Motion (Vrije Universiteit Brussel), que reproduce el apéndice de la versión española para fines académicos/clínicos no comerciales. El Protocolo.pdf de este acervo es una reconstrucción textual verificada (no el binario original del titular, que el entorno de red de este proceso no pudo descargar).

12. DOI / URL oficiales y referencias APA

Mayer TG, Neblett R, Cohen H, Howard KJ, Choi YH, Williams MJ, Perez Y, Gatchel RJ (2012). The development and psychometric validation of the central sensitization inventory. *Pain Practice*, 12(4), 276-285.

Cuesta-Vargas AI, Roldan-Jimenez C, Neblett R, Gatchel RJ (2016). Cross-cultural adaptation and validity of the Spanish central sensitization inventory. *SpringerPlus*, 5, 1837. <https://doi.org/10.1186/s40064-016-3515-4>

Neblett R (2018). The Central Sensitization Inventory: A User's Manual. *Journal of Applied Biobehavioral Research*, 23, e12123. <https://doi.org/10.1111/jabr.12123>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

13. Activos disponibles, hash y estado QA

Activos disponibles	Protocolo.pdf (reconstrucción textual verificada con reportlab, 25 ítems Parte A + 10 ítems Parte B). Ficha_Tecnica.docx / .pdf.
Hash / verificación	Ver MANIFIESTO_SHA256.csv del proyecto (generado por proceso externo posterior a esta entrega).
Estado QA	Protocolo reconstruido abre correctamente y contiene el texto íntegro verificado (comprobado con pypdf). Requiere revisión humana antes de uso clínico formal.

14. Control de versión

Fecha	2026-08-10
--------------	------------

Responsable	Claude — proceso automatizado, requiere revisión humana
Versión de la ficha	1.0